

10月工作情况总结

一、工作总结

事项	目标	完成情况	结果/产出	备注 (自评价值)
部门管理	通过周会、月会、绩效考核与项目计划管理，提升执行力与结果导向	【未完成】虽进行例会、执行绩效考核，但未形成推进效果；列项目拆解计划但无节点控制和检查	有管理动作但未产生实质效果，未形成良性循环	低
考试全覆盖	实现西医94个，中医53个考试覆盖	【已完成】统筹教研、研发、产品协作，明确上架节奏与优先级，协调处理异常情况	西医覆盖 92 个（2个取消） 中医覆盖43 个考试	高
题库年度更新	优化题目更新流程，实现全自动更新 - 实在无法更新题目删除/人工	【进行中】参与流程设计与问题项沟通	效率：有提升（自动更新率 85%，初级护师，去年44 小时→今年23 小时），人工耗时仍较高 质量：下降，新增知识点未生成题目	低
视频课程年度更新	以小成本保持课程时效性	【已完成】确定实现方案、比对提示词	护士资格、初级护师视频比对导出，由第三方剪辑更新	中
考纲深度解读	考纲二次传播，加深品牌	【已完成】设计解读视频逻辑	已规范化生成，待评估传播效果	中

二、存在问题

发现 / 被发现时间	问题描述	影响	改进措施	状态
10.16	绩效和奖惩导向不清晰 ：考核、表扬都有，但导向边界不清晰，没有清晰指出表扬的是能力（稳定输出），还是负责任、主动性	奖惩信号不清，团队容易模糊责任感	明确标准：结果导向+态度底线，公开规则，表扬/批评都能对应到标准上	解决中
10.27	问题停留在流程层面，没有管理杠杆思维 ：反思与改进只想到流程优化下、执行细节，未思考如何通过管理手段解决根本问题	问题易复发，缺少能自动约束与驱动的结构	重新梳理关键控制点，从职责、协同、绩效激励三方面设计机制	解决中
10.28	问题分层缺失，导致处理混乱 ：教研战略性问题与执行性问题混在一起，缺乏系统分层与归因，无法有效推动解决	问题无法聚焦，处理顺序和责任界面混乱	建立“问题分层与归因”机制，将问题分为战略层、执行层、使用层，明确每层责任与处理路径	未解决
10.29	对核心目标关注不足 ：在考纲发布等关键节点，未聚焦“第一时间发布、可阅读、可传播”等关键成效点	未达到最核心目标，影响传播与体验	推动目标复盘机制，每项任务明确“最关键成效点”，完成后检验是否真正触达目标	解决中
10.3	未形成从根因出发的系统性思维 ：习惯在问题暴露后补动作，不能识别结构缺陷、根本问题	造成问题重复、改进滞后	建立问题复盘机制，每次出现问题都追溯到根因层级，逐步固化成标准或制度	未解决

三、思考与改进

思考：

1、放下羞耻心，敢于面对真实问题

羞耻心让人逃避问题、掩饰短板，看似努力，其实避开了改进的根因。能坦然承认“我不会”“我没做好”，才能让学习和突破发生。尤其要接受被指出问题的过程，因为那是自我升级的最快路径。

2、以结果为起点，驱动高质量执行

执行前若陷入“怎么做”“别人能不能做”的犹豫，往往浪费时间、模糊产出。以终为始的思维要求先定义结果，再反推路径与资源，任务才会清晰、聚焦、有衡量标准。这种结果导向不仅提升个人执行质量，也能让团队目标一致、协作高效。

3、机制优于流程，结构优于努力

优化流程只能让事情“更顺”，无法让系统“自运转”。问题的根源常在于机制无力——责任边界模糊、激励结构缺失、反馈不闭环。通过建立可持续的管理杠杆，让规则能自动约束、激励能自然驱动，才能从根本上提升组织效率与执行力。

改进：

1、明确绩效标准，兼顾结果与过程质量

问题：绩效与结果脱节，员工靠“执行行为”而非“获得结果”取得收益。产品、开发等岗位只对上线节点或代码交付负责，不对效果、性能和体验负责，导致产出质量不稳、驱动力不足。

计划：

- 1) 11.3—11.7 明确绩效核算标准，确定公式结构，并细化结果与过程质量的评分标准。
- 2) 11.15 按半月度情况进行首次绩效初评，检验评分逻辑与标准可执行性。
- 3) 11.30 将绩效结果用于月度复盘与激励分配。

预期结果：

绩效考核更清晰、公平，能直接反映结果质量与个人贡献，促使团队在完成任务的同时真正对结果负责。

2、提高执行响应速度，让决策快速落地

问题：自己在推进上存在“决策到行动”的断层，容易犹豫、反复，导致节奏被拖慢、影响目的达成。

计划：

- 1) 每日 当日确定的事项当天分解、列入执行计划。
- 2) 每周五 总结完成率，对推进中断项说明原因并补齐。
- 3) 11.30 月总结执行效率提升情况。

预期结果：

工作节奏更紧凑，决策和行动同步推进，做到“定了就干、干了就结”。